

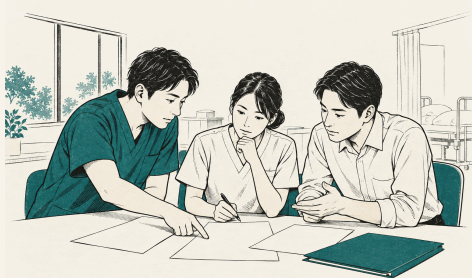
■ 診療報酬／回復期リハ病棟入院料2・3・4

回復期リハ入院料2～4の経過措置、9月30日で終了 届出は10月14日まで

厚労省が9/10に事務連絡 10/31までに受理されれば10/1に遡って算定可(報道)

対象は入院料2・3・4。令和8年3月31日時点で届出済みの病棟は、実績指数や週7日のリハビリ提供体制などの要件を、9月30日までみなしで満たすとされていた。入院料2・4では実績指数の基準が今回初めて設けられた。入院料1は同様の届出直しが8月12日必着で先に済んでいる。今回の期限

は10月14日で、10月31日までに受理されれば10月1日に遡って算定できるとされる。情報源は会員限定記事の公開部分と改定内容の解説で、事務連絡そのものは未確認。実績指数の算定期間など細部は、厚労省と各厚生(支)局の案内で原文を確認する。



実績指数と休日リハの体制を、10/14までに確認

出典 **1post** (PT・OT・ST向けメディア)



数字で見る

9/30

経過措置の終了日（令和8年度改定）

10/14

届出の期限（10/31までの受理で10/1に遡及）

42以上

入院料1のリハ実績指数の基準（届出直しは8/12必着で先行）

■ 脊髄損傷／回復経過

頸髄損傷後の下肢機能の回復は5つの経過に分かれる 日本516人

後ろ向き縦断コホート516人。各型に属する平均確率は0.91～0.98。年齢・AIS分類・骨損傷は特定の型と関連した。抄録に各型の割合やAIS別の数値はない。後ろ向きの単施設研究で、著者らは予後判断の理解に役立つ可能性という位置づ



け。

出典 **Arch Phys Med Rehabil**



■ 人工関節置換術後／ウェアラブル

足首ポンプ運動をセンサーで見守ると、術後7日の実施率は86%対64%

実施率の差22.0ポイント(95%CI 5.6 ～ 38.4、P=0.011)、満足度94%対78%。術後14日までのDVTは2%対6%で有意差なし(P=0.617)。重篤な有害事象なし。単施設・非盲検・小規模でDVTは検出力不足、アドヒアランス尺度は未



検証。血栓予防の効果は示せていない。

出典 **Front Rehabil Sci**



短 信

〈集中治療〉ICUのPT介入、3年後も提供率が維持

米国の大学病院MICU 13,058入院の前後比較。PT提供のオッズは約4倍、ICU滞在は微減。単施設のQI研究

出典 **Phys Ther**

〈ロボット〉歩行ロボット訓練、外骨格型のみ小さな効果

脳卒中20RCTのMA。歩行・バランスに小さな改善で、エンドエフェクタ型は有意な変化なし

出典 **J Back Musculoskelet Rehabil**

〈転倒予防〉地域高齢者の多要因転倒予防、効果は限定的

Cochrane更新・110RCT/48,919人。転倒率RaR 0.76だが確実性は低く、転倒予防の助言・教育との比較で上乘せなし

出典 **Cochrane Database Syst Rev**

〈遠隔リハ〉運動主体の遠隔心リハでVO2peak +2.58

心血管疾患13RCT・958人のMA。差2.58mL/kg/min、予測区間は0をまたぎ確実性は非常に低い 出典 **J Med Internet Res**

〈退院支援〉自宅退院した脳卒中、訪問診療の導入は10.9%

回復期病棟から自宅へ退院した129人中14人。FIM運動が低く高齢ほど導入。1postの記事による(原典は総合リハ科学)

出典 **1post**

〈栄養〉栄養ケアプロセスの病棟導入、有意差は残らず

愛知医大9病棟・65歳以上約1.7万人の差の差分析。低栄養層で死亡・在院日数の減少と関連したが多重比較補正後は非有意 出典 **JAMA Netw Open**(1post経由)

〈介護情報基盤〉リハビリ計画書も電子共有の検討対象に

9/18の社保審・介護保険部会。ケアプランデータ連携システムは令和9年1月に介護情報基盤へ統合予定と報告

出典 **1post**

〈透析〉透析中の運動指導、算定の担い手は看護師が主

栃木県57施設のうち23施設が加算を算定。担当は看護師17・PT3・OT0施設で、PTは10施設で実施時に在室

出典 **1post**(理学療法とちぎ)